

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083117-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: DENISE ALVES NOSCHANG

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FILA DE ESPERA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. VIA ADMINISTRATIVA PARA O CASO EM TELA JÁ ESTÁ SENDO UTILIZADA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5083117-86.2024.4.02.5101

510014963721 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083117-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: DENISE ALVES NOSCHANG

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos. Vejamos:

"Mister deixar consignado que em casos de pedidos de agendamento de consultas, internação ou intervenção cirúrgica, o papel do judiciário, em regra, é respeitar a decisão do órgão público, que fixa, de acordo com suas possibilidades materiais, critérios para atendimento dos casos que lhe chegam, o que equivale a dizer que o paciente deve se submeter às etapas de avaliação e à indicação de tratamento pela equipe médica do Sistema Único de Saúde.

Assim, a pretensão que acarrete a subtração de etapas do atendimento ou que pretenda a realização de consulta ou tratamento na frente de outras pessoas em igual situação ou simplesmente que tiveram acesso ao SUS antes, não deve, em princípio, merecer acolhida, sob pena de se perturbar, com a decisão judicial, a logística e organização administrativa.

A jurisprudência corrobora este entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. ORGANIZAÇÃO DE FILA DE ESPERA. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela antecipada para que a União, o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro priorizassem o tratamento da parte agravada, aferindo-se o real diagnóstico da enfermidade, e, constatada a necessidade de cirurgia, a realizassem imediatamente, no INTO ou em outra unidade hospitalar apta a efetivar o procedimento cirúrgico.

2. Em instituições e hospitais públicos, devem os pacientes necessitados de cirurgia aguardar o procedimento em fila de espera, organizada segundo critérios técnicos que considerem a entrada, a doença, a gravidade e o procedimento necessário, cabendo à Administração zelar pelo respeito à ordem estabelecida, visando afastar, na medida do possível, o risco à vida daqueles que, prioritariamente, aguardam cirurgias de alta complexidade.

3. Embora notórias as deficiências no SUS, com centenas de pacientes em listas de espera aguardando cirurgias, esse problema de saúde pública não pode e nem deve ser resolvido pelo Poder Judiciário, pena de desestruturar-se o SUS no compromisso de preservar a saúde de um

paciente sem desatender outros que também aguardam cirurgia, impondo-se sopesar, tão-somente, se a isonomia está sendo respeitada.

4. Não cabe ao Judiciário, sem conhecimentos médicos ou administrativos próprios, decidir, concretamente, se o paciente-autor deve ser tratado ou operado antes de outro, que também aguarda na fila, salvo quebrando o princípio da isonomia.

5. No exame da omissão ou atraso na realização de procedimentos cirúrgicos necessários, deve o magistrado corrigir somente eventuais vícios na organização da fila de espera para a sua prestação, não bastando, nessas hipóteses, alegações genéricas, sem a efetiva indicação do desvio, pena de se invadir a esfera de competência de outro Poder.

6. No caso, a autora é uma entre dezenas ou centenas de pacientes no mesmo estado de saúde, aguardando tratamento cirúrgico no INTO.

7. Agravo de Instrumento provido. (TRF 2ª Região, 6ª Turma Especializada, AG 2012.02.01.015232-3, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 16/01/2013).

Desse modo, o Judiciário está autorizado a intervir apenas nas hipóteses de desrespeito à ordem de atendimento.

A autora informou na inicial que, segundo a médica assistente, a demora para realização da cirurgia pode acarretar danos irreparáveis à função da língua, com cirurgia bastante mutiladora.

No caso sob análise, consultado o grupo de whatsapp (evento 3, CERT1), criado para obtenção célere de informações do âmbito de regulação, para instrução dos processos judiciais, foi informado que:

Paciente inserida na fila para Ambulatório 1ª vez - Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Oncologia no dia 23/9/24. Aguarda liberação de vaga em prestador habilitado.

Portanto, tendo em vista que a parte autora foi inserida no sistema de regulação recentemente, em 09/2024, e que encontra-se direcionada, consulta marcada em 23/09/2024, aguardando liberação para prestador habilitado, conforme informado, certa a mobilização da Administração, ao menos neste momento.

*Isto posto, por ora, **INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.***

Alega a parte recorrente que necessita, com urgência, ser encaminhada para hospital de referência a fim de realizar procedimento cirúrgico com cirurgião de cabeça e pescoço para retirada do tumor na língua.

Alega ainda que, a despeito de o possível diagnóstico de sua doença ter sido firmado há menos de 60 dias, conforme documentos médicos anexos, apresenta RISCO DE DANOS IRREPARÁVEIS À FUNÇÃO DA LÍNGUA, COM CIRURGIA BASTANTE MUTILADORA, o que evidencia a extrema gravidade do quadro e a necessidade de que o tratamento seja realizado de forma imediata.

Decisão do evento 10, indeferindo a liminar.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já fundamentado na decisão do evento 10. Vejamos:

De acordo com o verificado pelo Juízo de origem, a parte autora foi inserida em fila no dia 23/09/2024.

Tendo em vista que nos autos originários não houve a determinação de intimação do NAT para apresentar parecer, o que seria aconselhável a fim de verificar a necessidade e urgência do pleiteado, em observância ao enunciado 18 do CNJ (III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019), este Juízo determinou a remessa dos autos ao referido Núcleo.

Em resposta, o NAT apresentou parecer, informando que a cirurgia de cabeça e pescoço para avaliação de cirurgia de retirada de tumor em língua está indicada ao manejo da condição clínica da Autora - carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado de língua (Evento 1, ANEXO2, Páginas 16, 17, 19, 20), e que o procedimento é coberto pelo SUS.

Destacou também que, por se tratar de demanda cirúrgica, somente após a avaliação do médico especialista poderá ser definida a abordagem terapêutica mais adequada ao caso da Autora.

Por fim, informou que, em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER (ANEXO II), foi localizado para a Autora solicitação de Consulta - Ambulatório 1ª vez - Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Exceto Tireoide (Oncologia), CID: Neoplasia maligna da base da

língua, solicitado em 23/09/2024, pela Secretaria Municipal de São Gonçalo, **com situação: Agendada, para o dia 25/11/2024, às 08:30h, no Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE (Rio de Janeiro)**. Assim, considerando que o Hospital Universitário Pedro Ernesto pertence à Rede de Alta Complexidade Oncológica, entendeu o NAT que a via administrativa para o caso em tela já está sendo utilizada.

Ressalta-se que a Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia."

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente."

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único."

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º."

No caso concreto, como esclarecido pelo NAT, a consulta da parte autora já encontra-se agendada para o dia 25/11/2024.

Como já dito no despacho do evento 4, o pleito de realização de cirurgia sem observância da fila é possível, excepcionalmente, vez que a regra é a observância da fila. Havendo comprovação concreta, nos autos, da existência de risco de vida iminente ou alteração do quadro que justifique mudança na posição da fila, tal será possível, o que não restou comprovado nos autos. Até porque a consulta pretendida já foi marcada.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se.